

1. Introducción y relevancia clínica

Las **vasculitis** son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por **inflamación y daño de la pared de los vasos sanguíneos**, que puede comprometer **arterias, venas o capilares** de cualquier tamaño.

Este proceso inflamatorio produce **estenosis, oclusión, necrosis o aneurismas vasculares**, con isquemia y daño tisular de los órganos irrigados.

Según el **tamaño del vaso afectado**, las vasculitis se clasifican en:

- **Grandes vasos:** arteritis de células gigantes (temporal) y arteritis de Takayasu.
- **Vasos medianos:** poliarteritis nodosa (PAN) y enfermedad de Kawasaki.
- **Vasos pequeños:** granulomatosis con poliangeitis (Wegener), poliangeitis microscópica, síndrome de Churg-Strauss (ahora GPA eosinofílica), púrpura de Schönlein-Henoch, y crioglobulinemia mixta.

La relevancia clínica de las vasculitis radica en que pueden simular muchas patologías — desde fiebre prolongada y artralgias hasta insuficiencia renal o hemoptisis masiva— y su diagnóstico precoz es crucial para evitar daño irreversible.

En Chile, aunque son enfermedades poco frecuentes, las **vasculitis sistémicas primarias** son causa de hospitalización y consulta reumatológica, especialmente en adultos jóvenes y de mediana edad.

En el **EUNACOM**, este tema aparece en preguntas orientadas a:

- Reconocer el patrón de afectación por tipo de vaso.
- Diagnóstico mediante ANCA, biopsia o clínica característica.
- Tratamiento con corticoides e inmunosupresores.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las vasculitis se originan por una **respuesta inflamatoria anómala** dirigida contra componentes de los vasos sanguíneos, mediada por **autoanticuerpos, inmunocomplejos o mecanismos celulares**.

2.1. Mecanismos inmunopatológicos

1. Depósito de inmunocomplejos:

- Ejemplo: púrpura de Schönlein-Henoch (IgA), crioglobulinemia mixta, vasculitis inducida por fármacos.
- Los complejos activan el complemento y reclutan neutrófilos, causando daño endotelial.

2. Autoanticuerpos citoplásmicos antineutrófilos (ANCA):

- Característicos de vasculitis de pequeños vasos (granulomatosis con poliangitis, poliangitis microscópica, Churg-Strauss).
- Dos patrones principales:
 - **c-ANCA (anti-proteinasa 3):** asociado a granulomatosis con poliangitis.
 - **p-ANCA (anti-mieloperoxidasa):** asociado a poliangitis microscópica y Churg-Strauss.

3. Inflamación granulomatosa:

- Infiltración de linfocitos, macrófagos y células gigantes multinucleadas.
- Ejemplo: arteritis de Takayasu y arteritis temporal.

4. Daño mediado por células T:

- Libera citocinas (TNF- α , IL-6, IL-17) que perpetúan el proceso inflamatorio.

2.2. Clasificación clínica (EULAR/CHCC 2022)

- **Vasculitis de grandes vasos:** arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu.
- **Vasculitis de vasos medianos:** poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki.

- **Vasculitis de pequeños vasos:** ANCA positivas (GPA, MPA, EGPA) y ANCA negativas (Schönlein-Henoch, crioglobulinemia).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Las manifestaciones clínicas dependen del tamaño del vaso y del órgano afectado, pero hay síntomas generales comunes a casi todas las vasculitis:

3.1. Manifestaciones generales (comunes)

- Fiebre persistente, sudoración nocturna, pérdida de peso.
 - Artralgias, mialgias.
 - Fatiga y malestar general.
 - Anemia de enfermedad crónica.
-

3.2. Vasculitis de grandes vasos

A. Arteritis de células gigantes (temporal)

- Afecta adultos mayores (>50 años).
- Cefalea temporal, dolor en cuero cabelludo, claudicación mandibular.
- Pérdida visual súbita por neuropatía óptica isquémica.
- VSG muy elevada (>100 mm/h).
- Biopsia de arteria temporal: inflamación granulomatosa con células gigantes.

Comentario EUNACOM:

Ante un paciente >50 años con cefalea, VSG elevada y amaurosis súbita, iniciar corticoides de inmediato (prednisona o metilprednisolona IV) antes de confirmar el diagnóstico.

B. Arteritis de Takayasu

- Afecta mujeres jóvenes (<40 años).

- Claudicación de miembros superiores, diferencia de presión arterial >10 mmHg entre brazos.
 - Ausencia de pulsos en arterias radiales (“enfermedad sin pulso”).
 - Soplos en arterias subclavias o aorta.
 - Diagnóstico con angio-TAC o angio-RM.
-

3.3. Vasculitis de vasos medianos

A. Poliarteritis nodosa (PAN)

- Inflamación necrosante de arterias musculares medianas.
- No afecta capilares ni causa glomerulonefritis.
- Se asocia a infección por **hepatitis B**.
- Clínica: fiebre, pérdida de peso, mononeuritis múltiple, dolor abdominal (isquemia mesentérica), livedo reticularis, hipertensión.
- Biopsia: necrosis fibrinoide.
- ANCA negativo.

B. Enfermedad de Kawasaki

- Exclusiva de niños <5 años.
 - Fiebre ≥5 días + exantema + conjuntivitis bilateral no purulenta + labios fisurados + adenopatía cervical + cambios en extremidades (descamación).
 - Riesgo de aneurismas coronarios.
 - Tratamiento: inmunoglobulina IV + aspirina.
-

3.4. Vasculitis de pequeños vasos

A. Granulomatosis con poliangitis (Wegener)

- Afecta vías respiratorias superiores, pulmón y riñón.
- Rinorrea crónica, sinusitis, úlceras nasales, perforación del tabique.
- Hemoptisis, nódulos cavitados pulmonares.
- Glomerulonefritis rápidamente progresiva.
- c-ANCA positivo (anti-PR3).
- Biopsia: granulomas necrosantes.

B. Poliangeitis microscópica (MPA)

- Similar a la anterior, pero sin granulomas ni afectación de vías respiratorias altas.
- Compromiso renal y pulmonar frecuente (capilaritis alveolar).
- p-ANCA positivo (anti-MPO).

C. Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (Churg-Strauss)

- Pacientes con **asma** o rinitis alérgica de larga evolución.
- Eosinofilia periférica.
- Vasculitis necrosante con granulomas y eosinófilos.
- p-ANCA positivo (anti-MPO).

D. Púrpura de Schönlein-Henoch (IgA)

- Más frecuente en niños.
- Púrpura palpable en extremidades inferiores, dolor abdominal y artralgias.
- Puede causar glomerulonefritis IgA.

E. Crioglobulinemia mixta

- Asociada a hepatitis C.
- Púrpura, artralgias, glomerulonefritis y neuropatía periférica.

3.5. Diagnóstico diferencial general

- Lupus eritematoso sistémico.
- Endocarditis infecciosa (puede simular vasculitis por fenómenos embólicos e inmunológicos).
- Síndrome antifosfolípido.
- Reacciones medicamentosas.

4. Exámenes complementarios

- VSG y PCR elevadas.
- ANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos): c-ANCA y p-ANCA.
- Función renal y examen de orina: proteinuria, hematuria, cilindros.
- Biopsia de órgano afectado: confirma diagnóstico (piel, riñón, arteria temporal).
- Angiografía: en PAN o Takayasu para evaluar estenosis o aneurismas.
- Serología viral (hepatitis B y C).

5. Tratamiento (según MINSAL 2023, EULAR y UpToDate 2024)

El tratamiento busca **suprimir la inflamación y prevenir el daño orgánico**.

5.1. Corticoides

- Base del tratamiento en todas las vasculitis.
 - Prednisona 1 mg/kg/día; en casos graves, metilprednisolona 1 g/día IV por 3 días.
-

5.2. Inmunosupresores

- **Ciclofosfamida:** en formas graves (GPA, MPA).
 - **Azatioprina o metotrexato:** mantenimiento tras remisión.
 - **Rituximab (anti-CD20):** alternativa eficaz a ciclofosfamida en ANCA positivas.
 - **Micofenolato mofetil:** opción en compromiso renal moderado.
-

5.3. Tratamientos específicos

- **PAN asociada a hepatitis B:** antivirales + corticoides + plasmaféresis.
 - **Kawasaki:** inmunoglobulina IV + aspirina.
 - **Takayasu y arteritis temporal:** corticoides + tocilizumab (anti-IL6) en refractarios.
 - **Schönlein-Henoch:** manejo sintomático, corticoides si hay compromiso renal o abdominal severo.
-

5.4. Medidas generales

- Suspender fármacos gatillantes (hidralazina, propiltiouracilo).
 - Control de presión arterial y función renal.
 - Prevención de infecciones (vacunas antes de inmunosupresión).
 - Protección gástrica y ósea durante uso prolongado de corticoides.
-

6. Complicaciones

- **Insuficiencia renal crónica** (por glomerulonefritis necrosante).
- **Hemorragia alveolar difusa.**
- **Aneurismas o infartos viscerales.**

- **Ceguera (arteritis temporal no tratada).**
 - **Amputaciones por isquemia crítica.**
 - **Infecciones graves por inmunosupresión.**
-

7. Pronóstico

Depende del tipo de vasculitis y del órgano comprometido.

- **Arteritis temporal:** buen pronóstico si se trata precozmente.
- **Takayasu:** curso crónico con riesgo de recaídas.
- **Vasculitis ANCA positiva:** sobrevida a 5 años >80% con tratamiento.
- **PAN:** mortalidad elevada sin tratamiento (≈90%), pero baja <10% con inmunosupresión.

Factores de mal pronóstico:

- Compromiso renal o pulmonar.
 - Aneurismas viscerales múltiples.
 - Recaídas frecuentes.
 - Infecciones oportunistas.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **arteritis temporal** se presenta con cefalea, claudicación mandibular y VSG elevada → iniciar corticoides urgente.
2. En **PAN**, pensar en asociación con **hepatitis B**.

3. La **granulomatosis con poliangitis** se asocia a **c-ANCA positivo** y compromiso de vías respiratorias superiores y riñón.
4. La **poliangitis microscópica** es similar, pero **sin granulomas** y con **p-ANCA positivo**.
5. La **Churg-Strauss** se asocia a **asma y eosinofilia**.
6. En **Takayasu**, la diferencia de presión entre brazos y la ausencia de pulsos es característica.
7. En EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en **ANCA, órgano afectado y tratamiento inicial**.

Errores comunes:

- No iniciar corticoides en arteritis temporal con riesgo de pérdida visual.
 - No solicitar ANCA en sospecha de vasculitis de pequeños vasos.
 - Confundir PAN con vasculitis ANCA positiva (PAN es ANCA negativa).
 - Olvidar buscar hepatitis B o C en PAN o crioglobulinemia.
 - Suspender corticoides abruptamente sin terapia de mantenimiento.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. Las **vasculitis** son enfermedades inflamatorias de vasos sanguíneos clasificadas según el tamaño del vaso.
2. Las **grandes vasculitis** (arteritis temporal, Takayasu) cursan con síntomas isquémicos y VSG elevada.
3. Las **vasculitis de pequeños vasos ANCA positivas** (GPA, MPA, EGPA) afectan pulmón y riñón.
4. El **diagnóstico** se basa en clínica, ANCA, biopsia y exclusión de otras causas.
5. El **tratamiento principal** son **corticoides + inmunosupresores** según severidad.
6. En **EUNACOM**, las claves son: tipo de vaso, ANCA asociado y tratamiento inicial con corticoides.